



## Ministério da Saúde

Urgencia Nº: XX Data Urg.: xx-xx-xxxx xx:xx:xx  
Proc.: XXXX Identificação N. Utente: XXXX  
Nome: XXX  
Data Nasc.: XX/XX/XXXX (XX Anos) Prof XXXX Sexo: XXX  
Morada: XXXX  
Localidade: XXXX Telefone: XXXX

### Médico Família

Centro de Saúde: XXXXX  
Médico: XXXXXX

### Outros Dados

Causa : XXXXXX Proveniência: XXXXX  
Subsistema: XXXXXX  
Observações: XXXX

### Triagem

Data / Hora da Triagem: XXXXX  
Discriminador: xxxxx

Fluxograma : XXXX

Prioridade Clínica

Temperatura: Dor: XX

Glasgow: XXXXX

PEFR: Freq. Resp.: PA: /

Glicémia: Corpos cetónicos: Freq. card.: Ritmo de pulso:

Oxi. per.:

Mobilidade: XXXXXx

Especialidade: XXXXX Grupo: XXXXX Sala: XXXX

Queixa: XXXXX

Justificação Via Verde:

Triador: XXXXXXXX Nº. Mecanográfico: XXXX Ass.: \_

### Observações Médicas

02-Nov-2025 16:42:00 Dr(a). Marta Sequeira (HUC-URG\_MEDICA)

Mulher, 44A, recorre por palpitações de início súbito cerca das 14h30, rápidas, sustentadas, associadas a mal-estar geral, astenia e dispneia ligeira aos esforços. Sem pré-síncope/síncope. Nega dor torácica, opressão, irradiação, sudorese fria, febre, tosse, hemoptises ou edema MMII. Sem vômitos/diarreia; sem exteriorização hemática ou queixas sugestivas de exacerbação de Crohn. Nega consumo recente de álcool, estimulantes, cocaína ou descongestionantes nasais. Refere adesão habitual a apixabano, sem omissões recentes, e toma regular de bisoprolol 2,5 mg/dia. Episódios prévios de FA paroxística pouco frequentes, habitualmente autolimitados; sem cardioversão eléctrica prévia conhecida.

AP: FA paroxística; doença de Crohn ileocólica, clinicamente em remissão sob azatioprina/mesalazina; perturbação depressiva major em remissão parcial.

Apendicectomia 2015. Anemia ligeira previamente vigiada no contexto de DII. Alergia a sulfamidas - exantema maculopapular.

MH: apixabano 5 mg 2id, bisoprolol 2,5 mg id, azatioprina 100 mg id, mesalazina 1,2 g 2id, sertralina 100 mg id.

À admissão consciente, colaborante, orientada, discurso fluente. Ligeiramente ansiosa, sem sinais de dificuldade respiratória. TA 128/76 mmHg, FC 146 bpm irregular, FR 18 cpm, SatO<sub>2</sub> 98% AA, T 36,7°C, glicemia capilar 104 mg/dL. Bem perfundida, TEC <2 s, mucosas húmidas. Sem ingurgitamento jugular. AC: ritmo irregular, taquicárdico, sem sopros audíveis. AP: MV bilateralmente presente e simétrico, sem sibilos/crepitações. Abdómen plano, depressível, indolor, sem defesa ou massas. Sem edemas periféricos, gêmeos indolores e simétricos. Sem focalidade neurológica.

ECG 16h48: fibrilhação auricular, resposta ventricular rápida, FC média 148 bpm; QRS estreito, eixo intermédio, QTc 438 ms; sem supradesnivelamento ST, infradesnivelamentos significativos ou alterações agudas da onda T sugestivas de isquemia. Sem sinais electrocardiográficos de pré-excitação.

Colheitas efectuadas. Hb 12,1 g/dL, Ht 36,8%, leucócitos  $6,7 \times 10^9/L$ , neutrófilos  $4,2 \times 10^9/L$ , plaquetas  $241 \times 10^9/L$ . PCR 1,8 mg/L. Glicose 101 mg/dL, ureia 28 mg/dL, creatinina 0,78 mg/dL, TFG  $>90 \text{ mL/min/1,73m}^2$ . Na 139 mmol/L, K 4,2 mmol/L, Cl 104 mmol/L, Ca 9,3 mg/dL, Mg 1,9 mg/dL. AST 21 U/L, ALT 24 U/L, bilirrubina total 0,5 mg/dL. TSH 1,46 mUI/L, T4L 1,12 ng/dL. Troponina T ultrasensível 4 ng/L, sem critérios analíticos de lesão miocárdica aguda no contexto clínico. Sem alteração metabólica, electrolítica, renal ou tiroideia precipitante identificada.

Monitorizada em área de observação, hemodinamicamente estável, sem dor torácica ou sinais de IC aguda. Administrado metoprolol 5 mg EV lento, com redução progressiva da FC para 95-110 bpm. Cerca das 18h05, conversão espontânea para ritmo sinusal, FC 72 bpm, mantendo estabilidade clínica. ECG pós-conversão 18h14: ritmo sinusal, FC 71 bpm, PR 164 ms, QRS 86 ms, QTc 421 ms; sem alterações isquémicas agudas.

Reavaliada: assintomática, sem palpitações ou dispneia; TA 122/74 mmHg, FC 70-74 bpm regular, SatO<sub>2</sub> 99% AA. Discussão com Cardiologia de prevenção: manter anticoagulação sem interrupção; aumentar transitoriamente bisoprolol para 5 mg id, com vigilância de hipotensão/bradicardia e reavaliação breve em consulta de Cardiologia para ajuste de terapêutica/ponderação de estudo complementar. Explicados sinais de alarme: recorrência persistente de palpitações com FC elevada, síncope, dor torácica, dispneia agravada, hemorragia sob anticoagulação. Compreende e concorda.

### **Notas de Enfermagem**

16h40: admitida por palpitações; monitorização cardíaca contínua iniciada, acesso venoso periférico 20G MSD, colheitas enviadas.

17h02: administrado metoprolol EV conforme prescrição; sem reacção adversa, TA mantida.

18h15: monitor evidencia ritmo sinusal; utente refere melhora franca, sem queixas álgicas ou dispneia.

19h00: deambula sem tonturas, sinais vitais estáveis; alta acompanhada por familiar.

### **Diagnósticos**

(I48.0) - Fibrilhação auricular paroxística com resposta ventricular rápida, revertida espontaneamente após controlo de frequência.

(Z79.01) - Terapêutica anticoagulante crónica.

### **Medicação**

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco

02/11/2025 17:02 | 02/11/2025 17:02 | 02/11/2025 17:02 | Metoprolol 5 mg EV lento

02/11/2025 | 16/11/2025 | 02/11/2025 manhã | Bisoprolol 5 mg PO id

Manter apixabano 5 mg PO 2id e restante MH sem alterações.

### **MCDT Requisitados / Procedimentos Efectuados**

M10110 - ECG 12 derivações: FA com resposta ventricular rápida, FC 148 bpm, QRS estreito, sem alterações isquémicas agudas.

M10111 - ECG 12 derivações pós-terapêutica: ritmo sinusal, FC 71 bpm, sem alterações isquémicas agudas.

M31001 - Hemograma completo: Hb 12,1 g/dL; leucócitos  $6,7 \times 10^9/L$ ; plaquetas  $241 \times 10^9/L$ , sem citopenias relevantes.

M31020 - Bioquímica urgente/ionograma/função renal: creatinina 0,78 mg/dL, Na 139 mmol/L, K 4,2 mmol/L, Mg 1,9 mg/dL; sem alterações relevantes.

M31042 - Função tiroideia: TSH 1,46 mUI/L, T4L 1,12 ng/dL, eutiroidia analítica.

M31066 - Troponina T ultrasensível: 4 ng/L, negativa.

### **Destino do Doente**

Data: 02/11/2025 19:12

Destino: Alta para domicílio, orientada para consulta de Cardiologia em 1-2 semanas e vigilância pelo MF.

Médico: Dr(a). Marta Sequeira